

Fecha Última Actualización: 21-07-2022 22:04:53

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Lucila Gladys Palacios Perez	Rut : 5.524.195-3	N° Archivo : 0327866	N° Epicrisis
Edad : 75a 4m 24d	Fecha Nacto : 27/02/1947	Sexo : Femenino	312788
Dirección : Omar Herrera Gutierrez 1806 Casa /12	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 8564 6221	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx	Fecha Ingreso : 16/06/2022 04:19	Días Estadía : 35
Unidad de Egreso : Utac/ Utinx	Fecha Egreso : 21/07/2022 22:07	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

ACV

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 16/06
FI UPC: 16/06
FI UTAC: 26/06
FI UPC: 01/07

ANTECEDENTES

Paciente diestra, mRankin 2, con los siguientes antecedentes:

Médicos:

- Hipertensión arterial.
- Insuficiencia cardíaca congestiva FE desconocida.
- Enfermedad renal crónica etapa 3.
- Dislipidemia.

Medicamentos:

- Atorvastatina 20 mg al día.
- Carvedilol 25 mg al día.
- Amlodipino/Olmesartán (40/5) 1 al día.
- Oftafilm 1 gota SOS.

Quirúrgicos: Cesáreas (2).

Alergias: no refirió.

Hábitos: no refirió.

Inmunizaciones: COVID (3).

Familiares: madre falleció de ACV.

Sociales: Dueña de casa. 8 básico.

HISTORIA ACTUAL

Paciente con los antecedentes descritos, última vez vista bien a las 23.30 del 15/06. A las 01.00 llamó a sus hijas por parestesias de la mano derecha, al momento de verla la encontraron con disartria, paresia e hipoestesia braquial derecha, razón por la cual decidieron consultar. Ingresó a CASR a las 02.27 estable hemodinámicamente, afebril, se activó código Stroke. A la evaluación por neurología impresionó vigil, orientada, atenta, nomina, repetía y obedecía órdenes, disartria leve, destacando paresia braquial derecha, hipoestesia BC derecha, por lo que se calculó 4 puntos en la escala de NIHSS.

Fecha Epicrisis : 21/07/2022 22:04

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 21-07-2022 22:04:53

Página 2 de 4

Se solicitó estudio imagenológico, TC sin lesiones en parénquima, angioTC ateromatosis bulbo carotídeo izquierdo, con estenosis asociada.

Por déficit súbito de 3:50 horas de evolución se decidió inicio de trombolisis (protocolo ECASS) con tiempo puerta aguja de 60 minutos. Se calculó dosis para 80 kilos (72 mg, 10 % en bolo, resto en 1 hora). Inicialmente estable, con regresión del déficit (NIHSS 1 punto, error en mes) estable hemodinámicamente. A 20 minutos de iniciado el síntoma, paciente inició con cefalea aguda, y deterioro del nivel neurológico, con NIHSS 3 puntos (afasia leve, paresia de la mano derecha, desorientación) por lo que se solicitó TC de encéfalo que evidenció transformación hemorrágica, con hemorragia subaracnoidea.

Se suspendió trombolisis y se solicitó transfusión de crioprecipitado (10 unidades) y ácido tranexámico (1 gramo). Se decidió ingreso a UTAC aunque se traslada precozmente a UPC para proteger VA.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO (16/06):

1. Accidente cerebrovascular isquémico.
 - Transformación hemorrágica secundaria a trombolisis.
 - Ateromatosis carotídea izquierda.
2. Antecedentes.

EVOLUCIÓN:

Hemodinámica: Con requerimientos de NAD en dosis bajas en contexto de sedación, que se logran suspender sin mayor conflicto. Posteriormente tendencia a HTA, actualmente manejada con Hidralazina + Amlodipino.

Respiratorio: Requiere IOT para proteger VA con 1er ciclo 16/06 - 23/06, prolongada en contexto de NAVM tratada. Posterior a ello se extuba para continuar manejo en UTAC, sin embargo el 01/07 en contexto de episodio de estridor + desaturación que impresiona probable macroaspiración requiere nuevamente IOT. Evoluciona favorablemente, con PAFI en ascenso hasta 390, se realiza PVE con PS de forma exitosa, logrando extubarse el 06/07 con salida a CNAF, actualmente parámetros 40/27.

Neurología: Ingresa por ACV isquémico, en ventana para trombolisis, evolucionando con transformación hemorrágica. Se realizó TC de control inicial que evidenció aumento de HSA de las convexidades, iniciándose dexametasona por edema cerebral (ya suspendida) y fenitoína profiláctica. Con respecto a riesgo de presentar cuadro comicial, se ha mantenido Fenitoina (PHT), como profiláctica, niveles bajo rango. Hasta el momento sin clínica de crisis y EEG sin AE. (Último EEG 17/06: frecuente lentitud intermitente generalizada y DLG).

Etimológicamente impresiona infarto en relación a embolia arterio arterial por estenosis significativa de ACI izquierda. Realizándose los siguientes estudios complementarios:

- AngioTC ingreso: ateromatosis ACP bilateral con placa complicada a izquierda y estenosis significativa. Ateromatosis de V3-V4 izq, cálcica ACI a nivel de bulbo bilateral, cavernosa bilateral, V4 derecha.
- TC de encéfalo control (24/06): múltiples focos hiperdensos bien delimitados cortico subcorticales bilaterales, con escaso edema perilesional, asociado a hemorragia subaracnoidea extensa bilateral mayor a izquierda.
- RM de encéfalo con gadolinio pendiente (en contexto de sospecha de angiopatía amiloidea, por transformación hemorrágica de múltiples puntos y principalmente de localización cortico-subcortical, no se ha observado edema perilesional desproporcionado por lo que parece poco probable hemorragia en relación a localización secundaria).
- Factores de riesgo cerebrovascular: HbA1C 5.2 TSH 1.48 LDL 69 VDRL (-)
- Pendiente estudio de daño en órgano blanco: Ecocardiograma Transtorácico pendiente.

Sin protección secundaria con aspirina, dado transformación hemorrágica. Sin atorvastatina por sospecha de DILI y LDL 69.

Al extubarse posterior a 1er ciclo VMI logra conectar y emitir lenguaje coherente, aunque desconectada. Secuelada con hemiparesia faciobraquicrual derecha. Actualmente, posterior a 2do ciclo VMI cursando delirium mixto, manejado con Olanzapina y Propofol en dosis en descenso, emite lenguaje pero no conecta.

Infeccioso: Se resumen Hits infecciosos a continuación.

- NAVM Acinetobacter baumannii MR, SAMS y Klebsiella PN BLEE (CAET 23/06), cubierta con Colistin (FI 26/06). - Se pesquisó foco cutáneo (flebitis brazo derecho), se retiró CVC y se cultivó, resultado 15 UFC S. epidermidis, por lo que se agregó vancomicina (FI 26/06), completándose 7 días de tratamiento con buena respuesta. Dentro del resto del estudio infeccioso destacó: PCR SARS COV 2 (-) 27/06, PL no inflamatoria, por lo que se desestima foco meníngeo.
- Deterioro respiratorio 01/07 con LBA con tapon de pus en bronquio fuente izq, TC torax con foco condensacion en LSI y cultivo (+) para KPN BLEE y SAMS se ajusta tratamiento a Meropenem (FI 03/07) y Cloxacilina (FI 05/07), que se mantienen hasta la fecha. Dado ACBA tratado, y habiendo completado 10 días de Colistin (26/06-05/07) se suspende.

Renal: Destaca leve deterioro funcion renal desde 06/07 y tendencia a hipokalemia leve, obs tubulopatía por Colistin. Se

Fecha Epicrisis : 21/07/2022 22:04

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 21-07-2022 22:04:53

Página 3 de 4

mantiene con cargas K EV.

Ginecología: TC TAP (26/06) que informa teratoma anexial derecho. Se solicita evaluación para definir manejo de teratoma, equipo solicita CEA, Ca 19-9 y Ca 125. Reconsultar a equipo con resultado una vez más estable.

Hepático: Con incremento de pruebas hepáticas desde el 22/6 patrón colestásico, se interpretó como posible DILI a atorvastatina, ya suspendida, actualmente en mejoría, sin hiperbilirrubinemia.

Nutricional: Nutrición enteral por SNG con Diben a 50 cc/h, en seguimiento por equipo nutrición.

Profilaxis: IBP. Se reinicia HNF 07/07 con pase por neurología dado lesiones hemorrágicas en regresión.

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO

1. Neumonía intrahospitalaria - Foco condensación LSI
 - LBA 01/07/2022 (+) KPN BLEE + SAMS
 - IOT 2do ciclo 01/07 - 06/07
 - IOT 1er ciclo 16/06 - 23/06
 - NAVM ACBA tratada
 - Portación klebsiella NDM
2. AKI KDIGO I - Obs por Colistin
 - Hipokalemia leve
3. Delirium mixto
4. Accidente cerebrovascular isquémico izquierdo
 - Ateromatosis ACP bilateral y art carotídea izq estenosis significativa -- Trombolisis ECASS III
 - Transformación hemorrágica 2° a trombolisis - HSA convexidad bilateral + HIP múltiples
 - Sospecha angiopatía amiloidea
5. Lesión anexial en estudio, probable teratoma
6. DILI a ATV en resolución
7. Antecedentes: HTA, DLP, ICC, ERC estadio 3, obesidad, hipoacusia.

La paciente evoluciona tórpida, con episodio de compromiso de conciencia el 19/07, posterior a eso se decide en conjunto con la familia adecuación de esfuerzo terapéutico. Se indica BIC de morfina. El 21/07 a las 15:50 se constata fallecimiento y se extiende certificado

Diagnóstico de Egreso

Accidente Vascular Isquémico -
Infarto Cerebral, No Especificado -
Hemorragia Intracerebral - Transformación Hemorrágica Múltiple
Neumonía Bacteriana, No Especificada -
Aterosclerosis De Otras Arterias - Ateromatosis Aci Izquierda
Otros Delirios - Sd. Confusional Agudo Multifactorial

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :
Régimen Alimentario :
Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 21/07/2022 22:04

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 21-07-2022 22:04:53

Página 4 de 4

INTERNO

Bec. Sebastián Eduardo Mancilla

Becado/Residente

Andrés Felipe Silva Pozo

Médico Tratante (Staff)